# 回覆：急診場域早期辨識緩和醫療需求篩選表的設計依據與實證

## 核心定位

### 不是「臨終判定」

**是在急重症治療過程中，及早辨識可能具有緩和醫療需求的高風險病人，作為後續評估與轉介依據。**

急診脈絡：病況變化快、停留短、重大醫療決策急迫，且團隊多為首次接觸病人與家屬。

## 主要實證依據

### IPAL-EM：急診緩和醫療整合架構

急診除急救與急性疾病處置外，也經常照護晚期、慢性進展性及限制生命疾病病人；因此建議建立臨床篩選機制，早期辨識未滿足需求。

- **12個月死亡風險**
  Surprise Question
- **反覆急診 / 住院**
  醫療利用增加
- **症狀控制困難**
  身體或心理症狀
- **功能下降 / 營養惡化**
  進食困難、體重下降
- **複雜照護與重大決策**
  長照需求、ACP/DNR
- **高風險臨床情境**
  晚期癌、OHCA、長期氧療

# 本院本土化設計：兩階段篩選 + 明確啟動門檻

A 項疾病嚴重度 × B 項緩和需求指標，連結至評估、轉介與照護介入流程

**第一階段 A 項：**
**嚴重危及生命之疾病型態**

癌症末期、重度 COPD、重度肝硬化
末期腎衰竭、末期心血管疾病
嚴重神經退化疾病、ARDS，敗血症
多重器官衰竭、極度衰弱老人

**第二階段 B 項：**
**緩和醫療需求指標**

12 個月死亡風險、功能下降、症狀控制困難
反覆非預期急診 / 住院、體重下降、難癒合傷口、重大醫療決策需求，病人/家屬主動提出

**啟動門檻**

**A 項 ≥ 1 + B 項 ≥ 2**

**即建議進一步評估，是否轉介**
**安寧緩和照護團隊**

快速篩選 → 早期辨識 → 專業評估 → 即時轉介 → 照護介入

**設計精神：不單用診斷或預後決定轉介，而是整合疾病嚴重度、功能 / 症狀變化、醫療利用、重大決策與病人/家屬需求。**

**總結回覆**

**本篩選表以 IPAL-EM 與後續急診緩和醫療篩選實證為基礎，經本院急診 / 急診加護病房情境本土化，將安寧緩和照護介入時點前移。**

參考：Lamba et al., J Emerg Med 2014; Kirkland et al., Acad Emerg Med 2022 系統性回顧（35 篇/14 種篩選工具）